Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Стадии заболевания 4

2.5 Степень тяжести 4

2.6 Жалобы 5

3. Диагностика 5

3.1 Диагностические критерии 5

3.2 Физикальное обследование 5

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Аудиометрия и импедансометрия 5

3.5 Вестибулярные исследования 6

3.6 Лучевые методы исследования 6

3.7 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 7

4.1 Купирование приступа 7

4.2 Терапия в межприступном периоде 8

4.3 Хирургическое лечение 8

4.4 Медицинская реабилитация 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

5.1 Организация медицинской помощи 9

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Диагноз достоверной болезни Меньера устанавливается при наличии не менее двух спонтанных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов, сенсоневральной тугоухости на низких и средних частотах, подтверждённой аудиометрией во время или после приступа, флюктуирующих слуховых симптомов (слух, шум, ощущение полноты в ухе) и при отсутствии других причин.
- Обследование всех пациентов включает тональную пороговую аудиометрию для оценки степени тугоухости и импедансометрию (тимпанометрию и акустическую рефлексометрию) для исключения патологии среднего уха.
- Для купирования приступа применяются атропин или платифиллин подкожно, антигистаминные препараты (дименгидринат, дифенгидрамин) или бензодиазепины (лоразепам, диазепам) на срок не более 3 суток; ввиду тошноты и рвоты предпочтительно парентеральное введение препаратов.
- После перенесённого приступа, а также при повторении приступов чаще одного раза в 3 месяца применяют бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев и более.
- Если консервативное лечение в течение 6–12 месяцев неэффективно, переходят к хирургическому лечению: начинают со слухосохраняющих вмешательств, а деструктивные оставляют для второго этапа или для случаев социально незначимого слуха.
- Компьютерная томография (КТ) височных костей и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов необходимы для исключения новообразований, прежде всего акустической шванномы при односторонней сенсоневральной тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) является заболеванием внутреннего уха, которое характеризуется повторяющимися приступами системного головокружения, а также шумом в ушах и сенсоневральной тугоухостью.

2.2 Классификация

Согласно классификации Американской академии оториноларингологии и хирургии головы и шеи (AAO-HNS), выделяются четыре формы заболевания: несомненная, достоверная, вероятная и возможная.

Начало заболевания может быть различным. При кохлеарной форме вначале возникают слуховые расстройства, а затем вестибулярные. При классическом варианте слуховые и вестибулярные нарушения появляются одновременно: уже первый приступ головокружения сопровождается снижением слуха и шумом в ухе. Реже встречается вестибулярная форма, при которой заболевание начинается с приступов головокружения, а слуховые расстройства присоединяются позднее.

По данным ряда авторов, флюктуация слуха в сочетании с головокружением наблюдается у 82,7% пациентов, без головокружения у 17,3%; по другим данным, заболевание начинается с изолированной кохлеарной симптоматики у 54,4% пациентов, с классической картины у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Заболевание характеризуется триадой симптомов: приступами системного головокружения, шумом в ухе и тугоухостью. Приступ развивается внезапно, в любое время суток и года, на фоне полного здоровья и ничем не провоцируется. В ряде случаев ему предшествует аура в виде появления или усиления заложенности и шума в поражённом ухе. Приступ всегда сопровождается вегетативными проявлениями, прежде всего тошнотой и рвотой, длится несколько часов (чаще 4–6) и купируется самостоятельно, без применения лекарственных препаратов. Шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость, как правило, односторонняя и носит флюктуирующий характер. При аудиологическом исследовании определяется так называемая скалярная, или ложная сенсоневральная, тугоухость: горизонтальный или восходящий тип аудиометрической кривой с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги восприятия ультразвука в пределах нормы, отмечается латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха.

2.4 Стадии заболевания

Первая стадия (начальная). Приступы возникают редко, 1–2 раза в год или даже один раз в 2–3 года, продолжаются в среднем 1–3 часа и сопровождаются тошнотой и рвотой. Шум, заложенность или ощущение распирания в ухе возникают до или во время приступа, но постоянными симптомами не являются. Для этой стадии характерна флюктуация слуха: его ухудшение, как правило, перед приступом и последующее улучшение. Некоторые пациенты отмечают значительное улучшение слуха сразу после приступа и его снижение до прежнего уровня в течение последующих суток.

Вторая стадия (разгар заболевания). Приступы приобретают типичный характер, с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными проявлениями, и повторяются от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно. Шум в ухе беспокоит постоянно и усиливается во время приступа, ощущение заложенности и дискомфорта в поражённом ухе отмечается ежедневно, снижение слуха прогрессирует от приступа к приступу.

Третья стадия (затухающая). Типичные приступы урежаются или прекращаются, однако пациента постоянно беспокоит ощущение шаткости и неустойчивости. Отмечается выраженное снижение слуха на поражённое ухо, часто в процесс вовлекается второе ухо. Возможно развитие отолитовых кризов Тумаркина, то есть приступов внезапного падения вследствие резкого смещения отолитовых рецепторов и внезапной активации вестибулярных рефлексов; они могут приводить к серьёзным травмам.

> Длительность приступа в тексте рекомендации указана неодинаково: в общем описании клинической картины она составляет несколько часов (чаще 4–6), для первой стадии в среднем 1–3 часа, в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

С учётом частоты и длительности приступов и сохранности трудоспособности выделяются три степени тяжести. При тяжёлой степени приступы ежедневные или еженедельные, продолжительностью несколько часов, со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств; трудоспособность утрачена. При средней степени приступы еженедельные или ежемесячные, также продолжительностью несколько часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены; трудоспособность утрачивается во время приступа и в течение нескольких часов после него. При лёгкой степени приступы непродолжительные, ремиссии длятся месяцы или годы.

2.6 Жалобы

Пациенты предъявляют жалобы на приступы нарастающей глухоты, шум в ушах, периодическую потерю равновесия, головокружение, тошноту вплоть до рвоты.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается по критериям AAO-HNS (редакции 1972, 1985 и 1995 годов) и по критериям 2015 года, согласованным Обществом Барани, Европейской академией отологии и нейроотологии (EAONO), комитетом по равновесию AAO-HNS и Корейским обществом равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	Гистологически подтверждённый эндолимфатический гидропс; не менее двух приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; флюктуирующие слуховые симптомы (слух, шум, ощущение полноты в ухе).
Достоверная	Не менее двух спонтанных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; флюктуирующие слуховые симптомы; отсутствие других причин.
Вероятная	Не менее одного приступа головокружения; сенсоневральная тугоухость, подтверждённая по крайней мере однократной аудиометрией; шум или ощущение заложенности в поражённом ухе; отсутствие других причин, объясняющих симптомы.
Возможная	Приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия, но без явных приступов головокружения; отсутствие других причин, объясняющих симптомы.

3.2 Физикальное обследование

Необходимо комплексное общеклиническое обследование с участием терапевта и невролога. В его объём входят акуметрия (исследование слуха шёпотной и разговорной речью, камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче), оценка спонтанного нистагма, тест импульсного (быстрого) поворота головы (тест Хальмаги–Кертойза), статокоординаторные и статокинетические пробы (поза Ромберга, проба Фишера–Барре, ходьба по прямой и фланговая походка, проба на диадохокинез), позиционные пробы (проба Дикса–Холлпайка, roll-тест Пагнини–Макклюра).

3.3 Лабораторные исследования

Для дифференциальной диагностики выполняют общий (клинический) и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Аудиометрия и импедансометрия

Степень тугоухости определяют по данным тональной пороговой аудиометрии; исследование выполняется всем пациентам.

Импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия) также необходима каждому пациенту: она позволяет исключить патологию среднего уха.

При клинических признаках вероятной болезни Меньера, а также при неэффективности консервативной терапии гидропс лабиринта подтверждают с помощью определения порогов чувствительности к ультразвуку и его латерализации, электрокохлеографии (ЭКоГ) или дегидратационного теста, по отдельности или в сочетании.

К исследованию вызванной отоакустической эмиссии и регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) прибегают при противопоказаниях к МРТ головного мозга (например, при наличии металлических конструкций в теле), а также при сомнительных результатах тональной аудиометрии (подозрение на аггравацию или симуляцию).

При болезни Меньера на аудиограмме определяется скалярная, или ложная сенсоневральная, тугоухость: горизонтальный или восходящий тип кривой с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги восприятия ультразвука в пределах нормы, отмечается латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха. Возможно снижение амплитуды пиков спонтанной отоакустической эмиссии.

При ретрокохлеарном уровне поражения отмечается повышение порогов акустического рефлекса относительно нормальных порогов слышимости.

Критериями ретрокохлеарной дисфункции по данным КСВП являются отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков, следующих за I или III; удлинение межпикового интервала I–V более 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I менее 0,5, особенно в сочетании с другими изменениями. Диагностическое значение имеет также патологически большая межауральная разница параметров, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

Универсального метода выявления гидропса лабиринта не существует. Для подтверждения диагноза необходим широкий спектр исследований с оценкой результатов в динамике, при этом результаты в значительной степени зависят от стадии заболевания.

3.5 Вестибулярные исследования

Вестибулометрия необходима для дифференциальной диагностики в тех случаях, когда диагноз невозможно установить на основании клинических данных, а также при планировании хирургического лечения.

В межприступном периоде спонтанная вестибулярная симптоматика отсутствует, статическое и динамическое равновесие в пределах нормы, в том числе по данным постурографии (стабилографии). Во время приступа развивается периферический вестибулярный синдром: системное головокружение, тошнота, рвота, нарушение равновесия, горизонтальный вестибулярный нистагм. При вестибулометрии в межприступном периоде выявляется угнетение вестибулярной функции, более выраженное на стороне поражения.

По тем же показаниям (дифференциальная диагностика и планирование хирургического лечения) выполняют видеонистагмографию (ВНГ) с записью калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.6 Лучевые методы исследования

Из лучевых методов используют компьютерную томографию височных костей и магнитно-резонансную томографию головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Эти исследования позволяют исключить новообразования (при односторонней сенсоневральной тугоухости прежде всего акустическую шванному), демиелинизирующий процесс, нейроваскулярный конфликт, приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.7 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения, сопровождающиеся снижением слуха, ощущением распирания и шумом в ухе, тошнотой и рвотой
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Кратковременные приступы системного головокружения, возникающие при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Резко выраженное вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение различной степени выраженности и нарушения слуха вплоть до глухоты после травмы уха или на фоне хронического отита; симптомы провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто в сочетании с острой односторонней глухотой и шумом в ухе
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Прогрессирующее головокружение преимущественно вестибулярного характера с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Мигренозная головная боль при части приступов головокружения

4. Лечение

Лечение включает три направления: медикаментозное купирование приступа головокружения, медикаментозную профилактику в межприступном периоде и хирургическое лечение.

4.1 Купирование приступа

Для купирования острого приступа вестибулярного головокружения подкожно вводится #атропин или #платифиллин, которые блокируют афферентную импульсацию от раздражённого лабиринта. Знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Для купирования приступа применяются также дименгидринат или дифенгидрамин.

Препараты относятся к Н1-антигистаминным средствам, проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как вестибулярные блокаторы центрального действия. Их используют в первые сутки приступа, максимально до 3 суток.

В первые сутки острого головокружения, максимально до 3 суток, для купирования приступа допускается применение #лоразепама или #диазепама.

Ввиду тошноты и рвоты во время приступа предпочтительно парентеральное введение препаратов; по мере купирования симптомов возможен переход на таблетированные формы.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, возможно сублингвальное применение

Препарат	Доза
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Терапия в межприступном периоде

Бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки (суточная доза 48 мг) рекомендован после перенесённого приступа головокружения, а также при межприступном периоде менее 3 месяцев; курс составляет 2–3 месяца и более.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт активации центральной вестибулярной компенсации.

Курсами назначаются диуретики (калийсберегающие, тиазидные и др.) или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид. В рекомендации приведён пример схемы: в 1–3-й день по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём), в 7–9-й и 13–15-й дни по 1 таблетке утром. Курс подбирается индивидуально.

Петлевые диуретики не применяются ввиду возможного ототоксического действия. При длительном приёме ацетазоламида следует контролировать уровень электролитов крови и при необходимости восполнять их.

Всем пациентам рекомендуется диетотерапия: ограничение поваренной соли до 2 г в сутки, исключение глутамата натрия, сбалансированное питание, направленное на нормализацию обменных процессов, прежде всего водно-солевого обмена.

Потребление соли и готовых продуктов следует максимально ограничить, алкоголь, кофеин и никотин исключить, жидкость потреблять умеренно.

Плановую инфузионную дегидратационную терапию в первые 2 года заболевания повторяют с интервалом 6–12 месяцев, в последующем с интервалом 2–3 года. Конкретные препараты в рекомендации не указаны.

4.3 Хирургическое лечение

Показанием к хирургическому лечению является неэффективность консервативной терапии в течение 6–12 месяцев.

При первой и второй стадиях заболевания хирургическое лечение начинают со слухосохраняющих вмешательств: хордоплексустомии, интратимпанального введения глюкокортикоидов, обнажения (дренирования) эндолимфатического мешка или селективной лазеродеструкции ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

К деструктивным вмешательствам (интратимпанальное введение гентамицина, лазеродеструкция лабиринта, вестибулярная нейроэктомия) переходят вторым этапом при неэффективности слухосохраняющей операции или при социально незначимом слухе.

4.4 Медицинская реабилитация

При нарушении равновесия в межприступном периоде на третьей стадии заболевания вестибулярную функцию корригируют средствами лечебной физкультуры. Двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость со средними порогами слуха в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе выше 31 дБ является показанием к слухопротезированию.

При развитии соматоформных расстройств на фоне хронической вестибулярной дисфункции показана психолого-социальная реабилитация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с болезнью Меньера подлежат диспансерному наблюдению с ежегодным профилактическим осмотром для оценки эффективности терапии, контроля слуховой и вестибулярной функции.

К мерам профилактики рекомендация относит формирование здорового образа жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов посредством диспансерного наблюдения.

Пациенту рекомендуется избегать резких перепадов давления в среднем ухе (подводное плавание, резкое сморкание, авиаперелёты). В рационе ограничиваются углеводы, солёные, острые и жирные мясные продукты; ежедневно следует употреблять продукты, богатые калием (печёный картофель, творог, курага). Исключаются алкоголь, курение, кофеин и продукты с консервантами, особенно с глутаматом натрия. Следует избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

5.1 Организация медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-оториноларингологом в амбулаторных условиях.

При тяжёлом состоянии пациента показана госпитализация в оториноларингологическое отделение; при тяжёлом течении пациент госпитализируется бригадой скорой медицинской помощи непосредственно в специализированное оториноларингологическое отделение, минуя амбулаторное звено.

Критериями выписки являются прекращение или урежение приступов головокружения либо улучшение или стабилизация порогов слуха.

На течение и исход заболевания влияют его длительность и тяжесть, сопутствующая патология, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приступа указана неодинаково: в описании клинической картины «чаще 4-6 ч.», для первой стадии «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.
- Срок пересмотра не согласован: на титульном листе указано «пересмотр не позднее 2026», то есть через 2 года после утверждения, в приложении А2 указано обновление «каждые 3 года».
- В критериях качества для обследований указан УДД 4, тогда как для тех же рекомендаций в разделе 2 указан УДД 5.
- Схема применения ацетазоламида приведена в таблетках, без указания дозы в миллиграммах.
- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровни не указаны также для рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.

- Профилактика сформулирована через воспалительные заболевания ЛОР-органов «особенно в педиатрической практике», хотя рекомендация адресована взрослым, а воспаление среди причин заболевания не названо.
- Опечатки: «импендансометрии» вместо «импедансометрии», «Н3-гистаминовых» вместо «Н3-гистаминовых».